SIGUR PE FIECARE PACIENT™

Pregătire pentru examen: 150 de întrebări și răspunsuri

Tăieturi, tensiuni, poziții și teste clinice, din hărțile atlasului.
Pentru examen, practică sau recapitulare.

Atlas de Taping · Material educațional pentru profesioniști și studenți din domeniul sănătății. Nu înlocuiește diagnosticul medical.

Cuprins

1 · Întrebările 1–30

2 · Întrebările 31–60

3 · Întrebările 61–90

4 · Întrebările 91–120

5 · Întrebările 121–150

Pasul următor

PARTEA 1

Întrebările 1–30

Răspunsul e imediat sub întrebare: acoperă-l cu o foaie.

1. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Umăr — Supraspinos”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 1).

2. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Umăr — Supraspinos”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Braț în adducție la spate, gât înclinat lateral opus.

3. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Umăr — Infraspinos”?
Răspuns: Tăietură în y (harta 2).

4. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Umăr — Infraspinos”?
Răspuns: Ancoră 0% · cozi 15–25%. Poziția: Braț adus pe pieptul opus (adducție orizontală).

5. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Umăr — Deltoid”?
Răspuns: Tăietură în y (harta 3).

6. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Umăr — Deltoid”?
Răspuns: Ancoră 0% · benzi 15–25%. Poziția: Braț relaxat pe partea corpului.

7. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Umăr — Biceps (Porțiunea Lungă)”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 4).

8. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Umăr — Biceps (Porțiunea Lungă)”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Cot extins, umăr în extensie ușoară.

9. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Umăr — Stabilizare (Y + I)”?
Răspuns: Tăietură în y + i (harta 5).

10. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Umăr — Stabilizare (Y + I)”?
Răspuns: Y 15–25% · I în centru 50%. Poziția: Braț relaxat, umăr ușor rotit extern.

11. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Cervicală — Trapez Superior”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 6).

12. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Cervicală — Trapez Superior”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Cap înclinat spre partea opusă.

13. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Cervicală Și Trapez”?
Răspuns: Y inversat (harta 7).

14. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Cervicală Și Trapez”?
Răspuns: Ancoră 0% · cozi 15–25%. Poziția: Gâtul în flexie în timpul aplicării.

15. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Cervicală — Ridicătorul Scapulei”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 8).

16. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Cervicală — Ridicătorul Scapulei”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Cap flectat și rotit spre partea opusă.

17. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Cervicală — Postură (Două Benzi În I)”?
Răspuns: Două tăieturi în i (harta 9).

18. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Cervicală — Postură (Două Benzi În I)”?
Răspuns: Ancore 0% · benzi 15–25%. Poziția: Gât în flexie, umeri relaxați.

19. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Cervicală — Ștergere Limfatică”?
Răspuns: Tăietură în evantai (harta 10).

20. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Cervicală — Ștergere Limfatică”?
Răspuns: Ancoră 0% · benzi 0–20%. Poziția: Cap înclinat spre partea opusă.

21. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Lombar — Stea (Durere Locală)”?
Răspuns: Stea din benzi în i (harta 11).

22. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Lombar — Stea (Durere Locală)”?
Răspuns: Centru 25–50% · capete 0%. Poziția: Trunchi în flexie ușoară.

23. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Regiunea Lombară”?
Răspuns: Două tăieturi în i (harta 12).

24. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Regiunea Lombară”?
Răspuns: Ancore 0% · corpul benzii 15–25%. Poziția: Trunchiul aplecat în față.

25. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Lombar — Pătratul Lombar”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 13).

26. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Lombar — Pătratul Lombar”?

Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Pacient în decubit lateral, trunchi înclinat spre partea opusă.

27. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Sacru — Articulația Sacroiliacă”?

Răspuns: Tăietură în x (harta 14).

28. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Sacru — Articulația Sacroiliacă”?

Răspuns: Centru 25–50% · capete 0%. Poziția: Ușoară flexie a trunchiului.

29. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Lombar — Fascia Toracolombară”?

Răspuns: Tăietură în y (harta 15).

30. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Lombar — Fascia Toracolombară”?

Răspuns: Ancoră 0% · cozi 10–25%. Poziția: Trunchi în flexie.

PARTEA 2

Întrebările 31–60

Răspunsul e imediat sub întrebare: acoperă-l cu o foaie.

31. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Abdomen — Dreptul Abdominal”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 16).

32. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Abdomen — Dreptul Abdominal”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 25–35%. Poziția: Trunchi în extensie ușoară.

33. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Abdomen — Oblici”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 17).

34. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Abdomen — Oblici”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Rotație ușoară a trunchiului spre partea opusă.

35. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Abdomen — Diastază (Suport)”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 18).

36. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Abdomen — Diastază (Suport)”?
Răspuns: Centru 25–35% · capete 0%. Poziția: Decubit dorsal, genunchii flectați.

37. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Abdomen — Drenaj Limfatic”?
Răspuns: Tăietură în evantai (harta 19).

38. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Abdomen — Drenaj Limfatic”?
Răspuns: Ancore 0% · benzi 0–20%. Poziția: Decubit dorsal, abdomen relaxat.

39. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Abdomen — Disconfort Menstrual”?
Răspuns: Tăietură în x (harta 20).

40. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Abdomen — Disconfort Menstrual”?
Răspuns: Centru 25% · capete 0%. Poziția: Decubit dorsal.

41. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Genunchi — Rotulă”?
Răspuns: Tăietură în y + i (harta 21).

42. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Genunchi — Rotulă”?
Răspuns: Y 15–25% · I 50% în centru. Poziția: Genunchiul flectat în timpul aplicării.

43. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Genunchi — Ligament Colateral Lateral”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 22).

44. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Genunchi — Ligament Colateral Lateral”?
Răspuns: Centru 50–75% · capete 0%. Poziția: Genunchi în ușoară flexie.

45. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Genunchi — Tendon Rotulian”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 23).

46. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Genunchi — Tendon Rotulian”?
Răspuns: Centru 50–75% · capete 0%. Poziția: Genunchi flectat.

47. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Genunchi — Ligament Colateral Medial”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 24).

48. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Genunchi — Ligament Colateral Medial”?
Răspuns: Centru 50–75% · capete 0%. Poziția: Genunchi în ușoară flexie.

49. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Genunchi — Edem”?
Răspuns: Tăietură în evantai (harta 25).

50. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Genunchi — Edem”?
Răspuns: Ancore 0% · benzi 0–20%. Poziția: Genunchi flectat.

51. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Coapsă — Ischiogambieri”?
Răspuns: Tăietură în y (harta 26).

52. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Coapsă — Ischiogambieri”?
Răspuns: Ancoră 0% · cozi 15–25%. Poziția: Decubit ventral, genunchi extins, șold flectat dacă e posibil.

53. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Coapsă Anterioară”?
Răspuns: Tăietură în evantai (harta 27).

54. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Coapsă Anterioară”?
Răspuns: Ancoră 0% · benzi 0–15%. Poziția: Șoldul în ușoară extensie.

55. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Coapsă — Cvadriceps”?
Răspuns: Tăietură în y (harta 28).

56. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Coapsă — Cvadriceps”?

Răspuns: Ancoră 0% · cozi 25–35%. Poziția: Genunchi flectat.

57. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Coapsă — Banda Iliotibială”?

Răspuns: Tăietură în i (harta 29).

58. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Coapsă — Banda Iliotibială”?

Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Decubit lateral, genunchi în ușoară flexie.

59. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Coapsă — Edem / Echimoză”?

Răspuns: Tăietură în plasă (harta 30).

60. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Coapsă — Edem / Echimoză”?

Răspuns: Ancore 0% · benzi 0–20%. Poziția: Mușchiul în poziție de alungire.

PARTEA 3

Întrebările 61–90

Răspunsul e imediat sub întrebare: acoperă-l cu o foaie.

61. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Gambă — Solear”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 31).

62. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Gambă — Solear”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Genunchi flectat, gleznă în dorsiflexie.

63. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Gambă — Tibial Anterior”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 32).

64. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Gambă — Tibial Anterior”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Gleznă în flexie plantară.

65. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Gambă”?
Răspuns: Tăietură în y (harta 33).

66. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Gambă”?
Răspuns: Ancoră 0% · cozi 15–25%. Poziția: Piciorul în dorsiflexie și genunchiul întins.

67. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Gambă — Peronieri”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 34).

68. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Gambă — Peronieri”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 25–35%. Poziția: Gleznă în inversie.

69. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Gambă — Crampe Și Oboseală”?
Răspuns: Tăietură în plasă (harta 35).

70. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Gambă — Crampe Și Oboseală”?
Răspuns: Ancore 0% · benzi 0–20%. Poziția: Gleznă în dorsiflexie.

71. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Gleznă — Tendonul Lui Ahile”?
Răspuns: Tăietură în y + i (harta 36).

72. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Gleznă — Tendonul Lui Ahile”?
Răspuns: Y 15–25% · I în centru 50%. Poziția: Gleznă în dorsiflexie.

73. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Gleznă — Edem”?
Răspuns: Tăietură în evantai (harta 37).

74. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Gleznă — Edem”?
Răspuns: Ancore 0% · benzi 0–20%. Poziția: Gleznă în flexie plantară ușoară.

75. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Gleznă”?
Răspuns: Etrier în u (harta 38).

76. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Gleznă”?
Răspuns: Centru 50% · capete 0%. Poziția: Glezna la 90 de grade.

77. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Picior — Fascia Plantară”?
Răspuns: Tăietură în evantai (harta 39).

78. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Picior — Fascia Plantară”?
Răspuns: Ancoră 0% · benzi 15–25%. Poziția: Gleznă în dorsiflexie, degete în extensie.

79. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Picior — Hallux Valgus”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 40).

80. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Picior — Hallux Valgus”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 25–50% pe articulație. Poziția: Halucele adus manual în poziție corectată.

81. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Toracic — Romboizi”?
Răspuns: Tăietură în y (harta 41).

82. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Toracic — Romboizi”?
Răspuns: Ancoră 0% · cozi 15–25%. Poziția: Brațe încrucișate în față, umeri protractați.

83. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Toracic — Trapez Mijlociu”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 42).

84. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Toracic — Trapez Mijlociu”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 25–35%. Poziția: Brațe în față, umeri protractați.

85. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Toracic — Dorsalul Mare”?
Răspuns: Tăietură în y (harta 43).

86. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Toracic — Dorsalul Mare”?

Răspuns: Ancoră 0% · cozi 15–25%. Poziția: Braț ridicat deasupra capului, trunchi înclinat lateral opus.

87. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Toracic — Coaste Și Intercostali”?

Răspuns: Tăietură în evantai (harta 44).

88. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Toracic — Coaste Și Intercostali”?

Răspuns: Ancoră 0% · benzi 10–20%. Poziția: Brațul ridicat, expirație completă la aplicare.

89. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Regiunea Scapulară”?

Răspuns: Tăietură în x (harta 45).

90. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Regiunea Scapulară”?

Răspuns: Centru 25–50% · capete 0%. Poziția: Umerii în retracție în timpul aplicării.

PARTEA 4

Întrebările 91–120

Răspunsul e imediat sub întrebare: acoperă-l cu o foaie.

91. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Șold — Fesierul Mijlociu”?
Răspuns: Tăietură în y (harta 46).

92. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Șold — Fesierul Mijlociu”?
Răspuns: Ancoră 0% · cozi 15–25%. Poziția: Decubit lateral, coapsa de sus în adducție.

93. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Șold — Piriform”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 47).

94. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Șold — Piriform”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Decubit lateral, șold flectat și adus.

95. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Șold — Iliopsoas”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 48).

96. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Șold — Iliopsoas”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Șold în extensie (pacientul la marginea mesei).

97. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Șold — Bursită Trohanteriană”?
Răspuns: Stea din benzi în i (harta 49).

98. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Șold — Bursită Trohanteriană”?
Răspuns: Centru 25–50% · capete 0%. Poziția: Decubit lateral.

99. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Șold — Adductori”?
Răspuns: Tăietură în y (harta 50).

100. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Șold — Adductori”?
Răspuns: Ancoră 0% · cozi 15–25%. Poziția: Șold în abducție.

101. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Încheietură — Tunel Carpian”?
Răspuns: Tăietură în y (harta 51).

102. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Încheietură — Tunel Carpian”?
Răspuns: Ancoră 0% · cozi 15–25%. Poziția: Încheietură în extensie.

103. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Încheietură Și Antebraț”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 52).

104. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Încheietură Și Antebraț”?
Răspuns: Ancoră 0% · corpul benzii 15–25%. Poziția: Încheietura flectată în timpul aplicării.

105. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Încheietură — Stabilizare”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 53).

106. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Încheietură — Stabilizare”?
Răspuns: Centru 25–50% · capete 0%. Poziția: Încheietură neutră.

107. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Încheietură — De Quervain”?
Răspuns: Tăietură în i (harta 54).

108. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Încheietură — De Quervain”?
Răspuns: Ancoră 0% · bandă 15–25%. Poziția: Police flectat în palmă, încheietură în deviație ulnară.

109. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Mâna — Edem”?
Răspuns: Tăietură în plasă (harta 55).

110. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Mâna — Edem”?
Răspuns: Ancoră 0% · benzi 0–20%. Poziția: Pumn închis ușor.

111. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Cot — Epicondilită Laterală”?
Răspuns: Tăietură în y + i (harta 56).

112. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Cot — Epicondilită Laterală”?
Răspuns: Y 15–25% · I în centru 50%. Poziția: Cot extins, încheietură flectată.

113. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Cot — Epicondilită Medială”?
Răspuns: Tăietură în y + i (harta 57).

114. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Cot — Epicondilită Medială”?
Răspuns: Y 15–25% · I în centru 50%. Poziția: Cot extins, încheietură în extensie.

115. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Antebraț — Flexori”?
Răspuns: Tăietură în y (harta 58).

116. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Antebraț — Flexori”?

Răspuns: Ancoră 0% · cozi 15–25%. Poziția: Cot și încheietură în extensie.

117. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Cot — Triceps”?

Răspuns: Tăietură în y (harta 59).

118. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Cot — Triceps”?

Răspuns: Ancoră 0% · cozi 15–25%. Poziția: Cot flectat, braț ridicat.

119. Ce tăietură folosești pentru aplicarea „Cot — Edem”?

Răspuns: Tăietură în evantai (harta 60).

120. Ce tensiune și ce poziție a pacientului folosești la „Cot — Edem”?

Răspuns: Ancoră 0% · benzi 0–20%. Poziția: Cot în ușoară flexie.

PARTEA 5

Întrebările 121–150

Răspunsul e imediat sub întrebare: acoperă-l cu o foaie.

121. Cum faci testul „Testul Jobe (cutia goală)" și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Brațul la 90° în plan scapular, rotit intern (degetul mare în jos). Pacientul menține poziția, tu apeși în jos pe antebraț. Pozitiv: Durere sau slăbiciune: suprasolicitare a supraspinosului.

122. Cum faci testul „Rotație externă contra rezistenței" și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Cotul la 90°, lipit de trunchi. Pacientul rotește antebrațul spre exterior, tu te opui. Pozitiv: Durere sau slăbiciune: infraspinos și rotund mic.

123. Cum faci testul „Testul Speed" și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Cotul întins, antebrațul în supinație, brațul ridicat înainte la 90°. Tu apeși în jos pe antebraț. Pozitiv: Durere în partea din față a umărului: porțiunea lungă a bicepsului.

124. Cum faci testul „Arcul dureros" și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul ridică lateral brațul întins până sus, lent, apoi îl coboară. Pozitiv: Durere între 60° și 120°: structurile subacromiale (supraspinos, deltoid).

125. Cum faci testul „Testul de aprehensiune" și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul pe spate, brațul la 90° abducție și cotul la 90°. Rotești lent brațul spre exterior. Pozitiv: Senzația că umărul „iese": instabilitate; banda de stabilizare ca suport, nu ca tratament unic.

126. Cum faci testul „Palparea trapezului superior" și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul șezând. Prinzi în pensă fibrele superioare ale trapezului, de la gât spre umăr. Pozitiv: Punct dureros care reproduce durerea de ceafă sau de cap: trapez superior.

127. Cum faci testul „Testul de lungime al ridicătorului scapulei" și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul înclină capul înainte și îl rotește spre partea opusă, privind spre axilă. Pozitiv: Tensiune sau durere la unghiul superior al scapulei: ridicătorul scapulei.

128. Cum faci testul „Observarea posturii capului" și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Privești pacientul din profil, în picioare: urechea ar trebui să fie deasupra umărului. Pozitiv: Capul proiectat înainte și umerii rotați: suport postural cu două benzi în I.

129. Cum faci testul „Observarea scapulei la ridicarea brațelor" și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul ridică lent ambele brațe înainte, de mai multe ori. Privești omoplații din spate. Pozitiv: Marginea medială se dezlipește sau mișcarea e asimetrică: suport scapular.

130. Cum faci testul „Retracția scapulelor contra rezistenței” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul apropie omoplații; tu te opui la nivelul umerilor. Pozitiv: Durere între omoplați: romboizi sau trapez mijlociu.

131. Cum faci testul „Testul de lungime al dorsalului mare” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul pe spate, genunchii îndoiți, ridică brațele întinse deasupra capului. Pozitiv: Brațele nu ajung la masă sau spatele se arcuiește: dorsalul mare scurtat.

132. Cum faci testul „Flexia trunchiului din picioare” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul se apleacă lent înainte, cu genunchii întinși, apoi revine. Pozitiv: Durere locală, fără iradiere în picior: banda în stea sau în I pe zona lombară.

133. Cum faci testul „Înclinarea laterală” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul se înclină lateral, alunecând mâna pe coapsă. Pozitiv: Durere pe partea opusă înclinării, între coastă și creasta iliacă: pătratul lombar.

134. Cum faci testul „Testul FABER (Patrick)” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul pe spate, glezna pe genunchiul opus, lași genunchiul să coboare spre lateral. Pozitiv: Durere în zona sacroiliacă (fesă, spate jos): articulația sacroiliacă.

135. Cum faci testul „Ridicarea piciorului întins (SLR)” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul pe spate. Ridici lent piciorul întins. Pozitiv: Durere care coboară pe picior sub genunchi, cu amorțeală: posibilă iritație de nerv; banda NU e prima alegere.

136. Cum faci testul „Testul diastazei drepților abdominali” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacienta pe spate, genunchii îndoiți, ridică ușor capul. Palpezi linia mediană deasupra și sub ombilic. Pozitiv: Spațiu de peste două degete între mușchi: suport pentru diastază, împreună cu exerciții.

137. Cum faci testul „Observarea edemului sau a echimozei” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Privești și palpezi zona: umflătură moale, urma degetului rămâne după apăsare. Pozitiv: Edem sau echimoză după efort ori intervenție: aplicare de drenaj limfatic.

138. Cum faci testul „Testul Trendelenburg” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul stă într-un picior timp de 30 de secunde. Privești bazinul din spate. Pozitiv: Bazinul coboară pe partea piciorului ridicat: fesierul mijlociu slab.

139. Cum faci testul „Testul FAIR (piriform)” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul pe partea sănătoasă, șoldul și genunchiul flectate; apeși ușor genunchiul spre masă. Pozitiv: Durere în fesă: piriform.

140. Cum faci testul „Testul Thomas” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul pe spate la marginea mesei, trage un genunchi la piept; celălalt picior atârnă liber. Pozitiv: Coapsa se ridică de pe masă: iliopsoasul scurtat.

141. Cum faci testul „Palparea trohanterului mare” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul pe partea sănătoasă. Apeși pe proeminența osoasă laterală a șoldului. Pozitiv: Durere locală, care se agravează culcat pe acea parte: zona bursei trohanteriene.

142. Cum faci testul „Lungimea ischiogambierilor (90/90)” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul pe spate, șoldul la 90°, întinde genunchiul cât poate. Pozitiv: Lipsesc peste 20° până la extensie completă: ischiogambieri scurtați.

143. Cum faci testul „Testul Ober” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul pe partea sănătoasă; piciorul de sus întins, dus înapoi și lăsat să coboare. Pozitiv: Piciorul nu coboară sub orizontală: banda iliotibială tensionată.

144. Cum faci testul „Testul Ely” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Pacientul pe burtă. Îndoi genunchiul spre fesă. Pozitiv: Bazinul se ridică sau doare în fața coapsei: dreptul femural (cvadriceps).

145. Cum faci testul „Mobilitatea rotulei” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Genunchiul relaxat, întins. Miști rotula în sus, în jos și lateral, comparând cu cealaltă parte. Pozitiv: Durere sau mobilitate redusă în jurul rotulei: banda în Y pentru rotulă.

146. Cum faci testul „Testul în valgus” și ce sugerează dacă e pozitiv?

Răspuns: Genunchiul la 20–30°. Împingi genunchiul spre interior, ținând glezna. Pozitiv: Durere sau deschidere pe partea internă: ligamentul colateral medial.

147. De ce capetele benzii se pun fără tensiune?

Răspuns: Ca banda să nu tragă de piele și să nu se dezlipească; tensiunea se pune doar în corpul benzii.

148. Ce tensiune folosești pentru drenaj limfatic?

Răspuns: Între 0 și 20%, cu ancora spre ganglionii limfatici.

149. Cât timp poate sta banda pe piele?

Răspuns: De obicei 3–5 zile, dacă pielea o tolerează.

150. Ce faci înainte de prima aplicare la un pacient nou?

Răspuns: Test de toleranță cu o bucată mică și verificarea semnalelor de alarmă.

Pasul următor

Fă 30 de întrebări pe zi cu răspunsul acoperit. În 5 zile ai trecut prin tot atlasul.